

El autocateterismo intermitente (ISC) es una forma de vaciar la vejiga pasando usted mismo una sonda fina y suave, drenando la orina y retirándola — varias veces al día. Se usa cuando la vejiga no se vacía bien sola. Una vez aprendido, toma solo unos minutos, le da libertad y protege sus riñones.

Por qué se hace

Si la vejiga no se vacía por completo — tras ciertas cirugías, con una **vejiga neurogénica**, con prolapso o con una obstrucción de salida — la orina que queda puede causar infecciones, escapes y presión que daña los riñones. El ISC **vacía por completo la vejiga** según un horario, lo que resuelve estos problemas.

Por qué supera a una sonda permanente

- **Menos infecciones** que una sonda permanente (que se deja puesta)
- **Sin bolsa** y más libertad — nada conectado entre cateterismos
- Mejor protección a largo plazo para la vejiga y los riñones

Al principio parece difícil, pero la mayoría — y los cuidadores — lo aprenden rápido con ayuda de una enfermera.

APRENDA LOS TÉRMINOS

ISC

Autocateterismo intermitente — vaciar usted mismo la vejiga y luego retirar la sonda.

Sonda

Un tubo fino y suave que se pasa a la vejiga para drenar la orina.

Residuo posmiccional

La orina que queda en la vejiga después de orinar.

Vejiga neurogénica

Una vejiga que no funciona normalmente por un problema de los nervios.

Técnica limpia

Lavar las manos y la zona — limpia, no totalmente estéril.

Sonda permanente

Una sonda que se deja puesta con una bolsa (lo que el ISC ayuda a evitar).

¿DUELE? Por lo general no — la mayoría siente solo una leve presión, y las sondas modernas vienen prelubricadas y muy finas. Puede haber molestia leve o un poco de sangrado las primeras veces. Una enfermera le enseña paso a paso hasta que se sienta seguro de hacerlo solo.

Cómo hacerlo (técnica limpia)

- 1 **Lávese las manos** y reúna sus insumos; limpie la abertura.
- 2 **Inserte suavemente** la sonda lubricada hasta que salga orina; avance solo un poco más.
- 3 Deje que la vejiga **drene por completo** y luego retire la sonda despacio.
- 4 **Deseche** las sondas de un solo uso (o limpie las reutilizables según le indiquen) y lávese las manos.

Con qué frecuencia

- Suele ser **cada 4–6 horas** (unas 4–6 veces al día) — su equipo fija su horario.
- No lo omita — un horario regular evita el sobrellenado y las infecciones.
- Beba normalmente; registre la cantidad si se lo piden.

Bueno saber

- Puede hacerse en cualquier baño limpio; los insumos son discretos y portátiles.
- Algo de turbidez o bacterias es común — las infecciones urinarias se tratan solo si tiene **síntomas**.
- Se puede enseñar a los cuidadores si usted no puede hacerlo solo.

Llame a su equipo si tiene:

- **No puede pasar la sonda**, o sale poca o ninguna orina pero se siente lleno
- Fiebre, escalofríos o dolor de espalda o costado (posible infección)
- **Sangrado** continuo o dolor importante

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. El ISC vacía una vejiga que no se vacía sola — protege sus riñones y previene infecciones y escapes.
2. Use técnica limpia con un horario regular (a menudo cada 4–6 horas); una enfermera le enseñará hasta que sea fácil.
3. Suele ser indoloro y más seguro que una sonda permanente. Llame si no puede pasarla, no puede vaciar o tiene fiebre.